## Avaliação Fisioterapêutica Neurofuncional – Disfunção vestibular

**Nome:** _____
**Idade:** _____ **Data de Nascimento:** _____/_____/_____
**Sexo:** _____
**Endereço**: _____
**Telefone**: ( ) _____ **Profissão**: _____
**Escolaridade**: **Acompanhante**:

**Vícios (tabaco; álcool, se fumar colocar a quantidade [ex: maços/dia]):**

**Aspectos neurovegetativos**

**PA:** _____ **/** _____ mmHg **FC:** _____ bpm **SpO2:** _____%

**Comorbidades**

( ) Audição Normal ( ) Hipoacusia ( ) OD ou ( ) OE ( ) Uso de Aparelho Auditivo
( ) Alterações metabólicas
( ) Hipertensão
( ) Hipotensão Postural
( ) Doença Osteomuscular
( ) Doença do Aparelho Circulatório
( ) Doença do Aparelho Respiratório
( ) Doença do Sistema Nervoso
( ) Doença do Aparelho Geniturinário
( ) Doença do Olho e anexos
( ) Transtornos Mentais
( ) Neoplasias
( ) Outros:
Sistema visual:
Usa óculos? ( ) Sim ( ) Não Se sim, qual grau? D _____ E _____
Realizou cirurgias oftálmicas? ( ) Sim ( ) Não
Quando realizou a última consulta com oftalmologista? _____

| **MEDICAMENTO**<br>EX: LOSARTANA | **CONCENTRAÇÃO**<br>EX: 50 mg | **POSOLOGIA**<br>EX: 1-0-1 (MANHÃ E NOITE) | **VIA**<br>EX: ORAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**SINTOMAS RELACIONADOS À DISFUNÇÃO VESTIBULAR (PRESENTE OU AUSENTE)**

( ) Tontura (desequilíbrio/cabeça leve/sensação de desmaio)
( ) Vertigem ( sensação de que o ambiente ou o próprio corpo está girando ou se movendo)
( ) Cinetose (enjoo em meios de transporte e/ou realidade virtual)
( ) Cefaléia (dor de cabeça)
( ) Instabilidade postural
( ) Náusea
( ) Escurecimento da visão
( ) Sensação de desmaio iminente
( ) Zumbido
( ) Sensação de pressão no ouvido/entupido/abafado
( ) Hipersensibilidade a sons
( ) Ansiedade
( ) Vômito
( ) Distúrbio do sono
( ) Perda auditiva
( ) Distúrbio da memória e da concentração
( ) Sudorese / palidez / taquicardia
( ) Sentimento de medo
( ) Oscilopsia (sensação de que o ambiente ao seu redor está em constante movimento, mesmo quando está parado)
( ) Diplopia (visão dupla/vê um objeto duplicado)

**CARACTERIZAÇÃO DA QUEDA**

Queda nos últimos seis meses: ( ) Nenhuma ( ) uma ( ) duas ou mais

Medo de queda: ( ) Sim ( ) Não

Na queda houve restrição das atividades: ( ) Sim ( ) Não

**CARACTERIZAÇÃO DA VERTIGEM / TONTURA**

**Tempo de início da vertigem / tontura:**

( ) de 3 a 6 meses
( ) de 7 a 11 meses
( ) de 1 a 2 anos
( ) de 3 a 4 anos
( ) mais de 5 anos

**Duração da vertigem / tontura:**

( ) Dias
( ) Horas
( ) Minutos
( ) Segundos

**Periodicidade da vertigem / tontura:**

( ) Esporádica
( ) Frequente
( ) Mensal
( ) Semanal
( ) Diária

**POSIÇÕES OU ATIVIDADES RELACIONADAS À VERTIGEM/TONTURA:**

( ) Virando a cabeça
( ) Levantando-se da posição deitada
( ) Levantando-se da posição sentada
( ) Mudando de posição na cama
( ) Sentado parado
( ) Em pé
( ) Andando
( ) Quando ansioso
( ) Durante exercício
( ) Ambiente cheio (multidão)
( ) Reunião social
( ) Dirigindo
( ) Lendo livro/jornal
( ) Trabalho no computador ou celular
( ) Assistindo televisão
( ) Cervicalgia
( ) Estresse
( ) Andar sobre pisos estampados**

# ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE VERTIGEM OU TONTURA OU DESEQUILIBRIO

1.Caminhar no corredor do supermercado




0 = Sem desconforto 10 = Desconforto máximo

2. Ser passageiro no carro




0 = Sem desconforto 10 = Desconforto máximo

3. Estar sob luzes fluorescentes



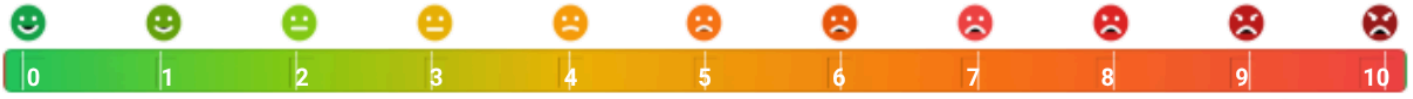

0 = Sem desconforto 10 = Desconforto máximo

4. Observar trânsito intenso no cruzamento



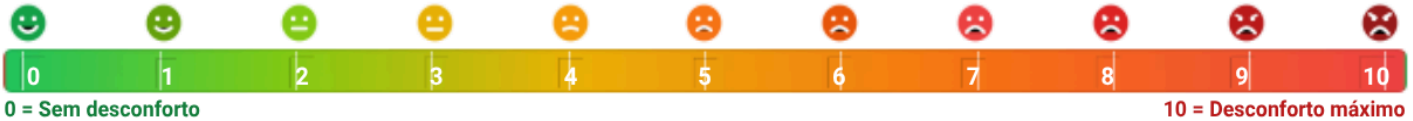

0 = Sem desconforto 10 = Desconforto máximo

5. Caminhar no centro comercial / shopping



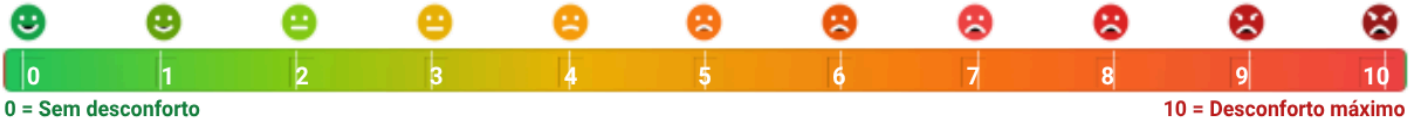

0 = Sem desconforto 10 = Desconforto máximo

6. Descer escadas rolantes



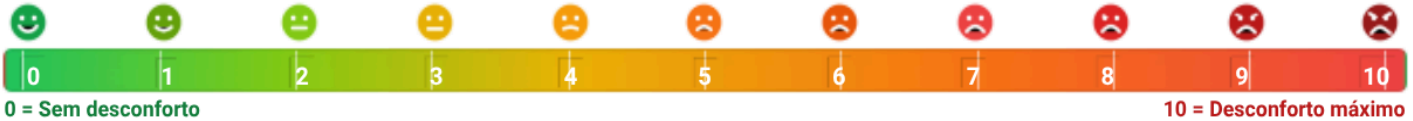

0 = Sem desconforto 10 = Desconforto máximo

7. Ver um filme no cinema




0 = Sem desconforto 10 = Desconforto máximo

8. Caminhar sobre um chão com padrões / estampas




0 = Sem desconforto 10 = Desconforto máximo

9. Ver um filme de ação na TV




0 = Sem desconforto 10 = Desconforto máximo

## VERSÃO BRASILEIRA DO DIZZINESS HANDICAP INVENTORY (DHI)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01.** Olhar para cima piora a sua tontura? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **02.** Você se sente frustrado(a) devido a sua tontura? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **03.** Você restringe suas viagens de trabalho ou lazer por causa da tontura? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **04.** Andar pelo corredor de um supermercado piora a sua tontura? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **05.** Devido a sua tontura, você tem dificuldade ao deitar-se ou levantar-se da cama? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **06.** Sua tontura restringe significativamente sua participação em atividades sociais tais como: sair para jantar, ir ao cinema, dançar ou ir a festas? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **07.** Devido a sua tontura, você tem dificuldade para ler? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **08.** Sua tontura piora quando você realiza atividades mais difíceis como esportes, dançar, trabalhar em atividades domésticas tais como varrer e guardar a louça? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **09.** Devido a sua tontura, você tem medo de sair de casa sem ter alguém que o acompanhe? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **10.** Devido a sua tontura, você se sente envergonhado na presença de outras pessoas? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **11.** Movimentos rápidos da sua cabeça pioram a sua tontura? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **12.** Devido a sua tontura, você evita lugares altos? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **13.** Virar-se na cama piora a sua tontura? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **14.** Devido a sua tontura, é difícil para você realizar trabalhos domésticos pesados ou cuidar do quintal? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **15.** Por causa da sua tontura, você teme que as pessoas achem que você está drogado(a) ou bêbado(a)? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **16.** Devido a sua tontura é difícil para você sair para caminhar sem ajuda? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **17.** Caminhar na calçada piora a sua tontura? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **18.** Devido a sua tontura, é difícil para você se concentrar? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **19.** Devido a sua tontura, é difícil para você andar pela casa no escuro? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **20.** Devido a sua tontura, você tem medo de ficar em casa sozinho(a)? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **21.** Devido a sua tontura, você se sente incapacitado? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **22.** Sua tontura prejudica suas relações com membros de sua família ou amigos? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **23.** Devido a sua tontura, você está deprimido? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **24.** Sua tontura interfere em seu trabalho ou responsabilidades em casa? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |
| **25.** Inclinar-se piora a sua tontura? | **Sim** | **Não** | **Ás vezes** |

Aspectos físicos – questões 01, 04, 08, 11, 13, 17 e 25;
Aspectos funcionais – questões 03, 05, 06, 07, 12, 14, 16, 19 e 24;
Aspectos emocionais – questões 02, 09, 10, 15, 18, 20, 21, 22 e 23.

**Escores:** Aspectos Físicos: / Aspectos Funcionais: / Aspectos Emocionais: / Escore final:

**Para cada resposta considere: Sim: 04 pontos / Às vezes: 02 pontos Não: 0 pontos.**
O escore final é a somatória dos pontos obtidos em todos os aspectos e por meio deste se classifica a tontura em **leve (0 a 30 pontos), moderada (31 a 60 pontos) ou severa (61 a 100).**

**Classificação da tontura: ( ) Leve ( ) Moderada ( ) Severa**

Grigol TAAS, Silva A, Ferreira MM, Manso A, Ganança MM, Caovilla HH. Dizziness Handicap Inventory and Visual Vertigo Analog Scale in Vestibular Dysfunction. **Int. Arch. Otorhinolaryngol**. 2016;20(3): 241-243

| **VERSÃO BRASILEIRA DAS SUBESCALAS VESTIBULAR *ACTIVITIES AND PARTICIPATION MEASURE*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Devido à sua tontura e/ou desequilíbrio corporal, quanta dificuldade você vem tendo na última semana para:** | **Nenhuma** | **Leve** | **Moderada** | **Grave** | **Incapaz** | **NA** |
| **Subescala 1 (VAP1-BR)** | | | | | | |
| **Prestar atenção (concentração, relembrar)** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Deitar-se (ir para a cama ou sair da cama) ou virar-se na cama** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Levantar-se a partir da posição sentada** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Curvar-se ou pegar objetos no chão** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Levantar e carregar objetos** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Esportes (envolver-se em jogos organizados em nível competitivo, formais ou informais, sozinho ou em grupo)** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Subescala 2 (VAP2-BR)** | | | | | | |
| **Caminhar distâncias longas** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Subir ou descer (degraus, elevador ou escada rolante)** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Correr** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Mover-se dentro de prédios que não sejam sua casa** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Utilizar meios de transporte (transporte público ou privado – sendo um passageiro)** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Guiar um veículo: dirigir um carro ou andar de bicicleta** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | |

**VAP1-BR: atividades difíceis de realizar pela propensão de provocar sintomas vestibulares; VAP2-BR: atividade e participação referente à mobilidade.**

LIRA, Maria das Graças de Araújo. **Versão brasileira da Vestibular Activities and Participation measure: adaptação transcultural, validade e confiabilidade**. Orientadora: Karyna Myrelly Oliveira Bezerra de Figueiredo Ribeiro. 2022. 64f. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022.

## AVALIAÇÕES FÍSICAS

### TESTES OCULARES

**Teste de força da motricidade ocular:**

| Músculo | Função Principal | Limitação | Mov. Conjugado |
|---|---|---|---|
| Reto superior | Eleva o olho e contribui para adução e rotação medial | | |
| Reto inferior | Abaixa o olho e contribui para adução e rotação lateral | | |
| Reto Lateral | Abduz o olho | | |
| Reto Medial | Aduz o olho | | |
| Oblíquo superior | Abaixa e roda medialmente | | |
| Oblíquo inferior | Eleva e roda lateralmente | | |

**Convergência ocular:**

| Ponto próximo de convergência (cm) | Observações |
|---|---|
| | |

**Movimento sacádico dos olhos:**

| Parâmetro | Normal | Alterado | Observações |
|---|---|---|---|
| Velocidade | | | |
| Precisão | | | |
| Início do movimento | | | |

**Perseguição ocular:**

| Direção testada | Resposta | Observações |
|---|---|---|
| Horizontal | ☐ Normal ☐ Alterado | |
| Vertical | ☐ Normal ☐ Alterado | |

**TESTES VESTIBULARES**

**Pesquisa de Nistagmo espontâneo e semi-espontâneo:**

| Tipo | Presença | Direção/ Característica | Condição de aparecimento |
|---|---|---|---|
| Espontâneo | ☐ Sim ☐ Não | | |
| Provocado por movimento ocular | ☐ Sim ☐ Não | | |
| Provocado por mudança de cabeça | ☐ Sim ☐ Não | | |
| Provocado por head shaking | ☐ Sim ☐ Não | | |

**Skew Deviation:**

| |
|---|
| ☐ Sem desvio |
| ☐ Desvio Vertical |
| ☐ Desvio horizontal |

**Teste impulso cefálico (RVO):**

| Lado testado | Presença de Reflexo | Observação |
|---|---|---|
| Direito | ☐ Normal ☐ Alterado | |
| Esquerdo | ☐ Normal ☐ Alterado | |

**Supressão do RVO:**

| Condição | Resultado | Observações |
|---|---|---|
| Fixação Ocular durante movimento cefálico | ☐ Preservada<br>☐ Prejudicada | |

**Teste de Fukuda:**

( ) Apresenta sintomas:_____

Resultado:

## MINI BESTest - Avaliação do Equilíbrio – Teste dos Sistemas

Os indivíduos devem ser testados com sapatos sem salto ou sem sapatos nem meias. Se o indivíduo precisar de um dispositivo de auxílio para um item, pontue aquele item em uma categoria mais baixa. Se o indivíduo precisar de assistência física para completar um item, pontue na categoria mais baixa (0) para aquele item.

**1. SENTADO PARA DE PÉ**

(2) Normal: Passa para de pé sem a ajuda das mãos e se estabiliza independentemente
(1) Moderado: Passa para de pé na primeira tentativa COM o uso das mãos
(0) Grave: Impossível levantar de uma cadeira sem assistência – OU – várias tentativas com uso das mãos

**2. FICAR NA PONTA DOS PÉS**

(2) Normal: Estável por 3 segundos com altura máxima
(1) Moderado: Calcanhares levantados, mas não na amplitude máxima (menor que quando segurando com as mãos) OU instabilidade notável por 3 s
(0) Grave: ≤ 3 s

**3. DE PÉ EM UMA PERNA**

**Esquerdo**
Tempo (em segundos) Tentativa 1: _____
Tentativa 2: _____
(2) Normal: 20 s
(1) Moderado: < 20 s
(0) Grave: Incapaz

**Direito**
Tempo (em segundos) Tentativa 1: _____
Tentativa 2: _____
(2) Normal: 20 s
(1) Moderado: < 20 s
(0) Grave: Incapaz

**4. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – PARA FRENTE**

(2) Normal: Recupera independentemente com passo único e amplo (segundo passo para realinhamento é permitido)
(1) Moderado: Mais de um passo usado para recuperar o equilíbrio
(0) Nenhum passo, OU cairia se não fosse pego, OU cai espontaneamente

**5. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – PARA TRÁS**

(2) Normal: Recupera independentemente com passo único e amplo
(1) Moderado: Mais de um passo usado para recuperar o equilíbrio
(0)Grave: Nenhum passo, OU cairia se não fosse pego, OU cai espontaneamente

**6. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – LATERAL**

**Esquerdo**

(2) Normal: Recupera independentemente com um passo (cruzado ou lateral permitido)
(1) Moderado: Muitos passos para recuperar o equilíbrio
(0) Grave: Cai, ou não consegue dar passo

**Direito**

(2) Normal: Recupera independentemente com um passo (cruzado ou lateral permitido)
(1) Moderado: Muitos passos para recuperar o equilíbrio
(0) Grave: Cai, ou não consegue dar passo

**7. OLHOS ABERTOS, SUPERFÍCIE FIRME (PÉS JUNTOS) (Tempo em segundos: _____ )**

(2) Normal: 30 s
(1) Moderado: < 30 s
(0) Grave: Incapaz

**8. OLHOS FECHADOS, SUPERFÍCIE DE ESPUMA (PÉS JUNTOS) (Tempo em segundos: _____)**
(2) Normal: 30 s
(1) Moderado: < 30 s
(0) Grave: Incapaz

**9. INCLINAÇÃO – OLHOS FECHADOS (Tempo em segundos: _____)**
(2) Normal: Fica de pé independentemente 30 s e alinha com a gravidade
(1) Moderado: Fica de pé independentemente < 30 s OU alinha com a superfície
(0) Grave: Incapaz de ficar de pé > 10 s OU não tenta ficar de pé independentemente

**10. MUDANÇA NA VELOCIDADE DA MARCHA**
(2) Normal: Muda a velocidade da marcha significativamente sem desequilíbrio
(1) Moderado: Incapaz de mudar velocidade da marcha ou desequilíbrio
(0) Grave: Incapaz de atingir mudança significativa da velocidade E sinais de desequilíbrio

**11. ANDAR COM VIRADAS DE CABEÇA – HORIZONTAL**
(2) Normal: realiza viradas de cabeça sem mudança na velocidade da marcha e bom equilíbrio
(1) Moderado: realiza viradas de cabeça com redução da velocidade da marcha
(0) Grave: realiza viradas de cabeça com desequilíbrio

**12. ANDAR E GIRAR SOBRE O EIXO**
(2) Normal: Gira com pés próximos, RÁPIDO (≤ 3 passos) com bom equilíbrio
(1) Moderado: Gira com pés próximos, DEVAGAR (≥ 4 passos) com bom equilíbrio
(0) Grave: Não consegue girar com pés próximos em qualquer velocidade sem desequilíbrio

**13. PASSAR SOBRE OBSTÁCULOS**
(2) Normal: capaz de passar sobre as caixas com mudança mínima na velocidade e com bom equilíbrio
(1) Moderado: passa sobre as caixas porém as toca ou demonstra cautela com redução da velocidade da marcha.
(0) Grave: não consegue passar sobre as caixas OU hesita OU contorna

**14. "GET UP & GO" CRONOMETRADO COM DUPLA TAREFA**
**TUG:_____ segundos** **TUG dupla tarefa _____ segundos**

(2) Normal: Nenhuma mudança notável entre sentado e de pé na contagem regressiva e nenhuma mudança na velocidade da
marcha no TUG
(1) Moderado: A tarefa dupla afeta a contagem OU a marcha
(0) Grave: Para de contar enquanto anda OU para de andar enquanto conta

**Pontuação total:**

**MiniBest (28 pontos)**

**50 a 59 anos de idade – 26,3 (IC: 25,7 – 26,8);**
**60 a 69 anos de idade – 24,7 (IC: 23,6 – 25,8);**
**70 a 79 anos de idade – 21,0 (IC: 19,5 – 22,4);**
**80 a 89 anos de idade – 19,6 (IC: 17,6 – 21,6) (SACHIO'HOSHI et al., 2013).**

MAIA, Angelica C.; RODRIGUES-DE-PAULA, Fatima; MAGALHAES, Livia C.; TEIXEIRA, Raquel L. L.. Cross-cultural adaptation and analysis of the psychometric properties of the Balance Evaluation Systems Test and MiniBESTest in the elderly and individuals with Parkinson's disease: application of the rasch model. Brazilian Journal Of Physical Therapy, [S.L.], v. 17, n. 3, p. 195-217, jun. 2013. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s1413-35552012005000085.